

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : منال سيد فرج محمود

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : البدرشين

رقم البطاقة : 27811092100987 رقم التليفون : 01120667429

العمر(تاريخ الميلاد) : 09-11-1978 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----)

المقر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : -----

GRI-E

جورستان افغانستان

روستا پيلاډني

لدى حساب

موسى رمضان

صحة الحسابات المرفعة

للجنة و مدير

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د.ا ----- / د.ا

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال سيد فرح محمود National ID: 27811092100987	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

منال
سيد فرج محمود
قرية كفر زهران
مركز البدرشين - الجيزة

١٩٧٨/١١

٢٧٨١١.٠٩٢١.٠٠٩٨٧

LT2705880



٢٠٢٦/٠٥ ٢٧٨١١.٠٩٢١.٠٠٩٨٧

ربة منزل

متزوجة
مسلعة
انثى
حسنى حسنين على ابوالعنين
البطاقة مارية حتى ٢٠٢٣/٠٥/٠٤



PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: منال سيد فرج محمود

Age: 48years

Sex: female

Request type: مبادره

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.:387B-2026

Department: صحنه مرأه

Date of result:

Referred by: د/هدايه نور

Date of biopsy:14/5/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number:27811092100987

Clinical diagnosis: Left breast mass

Gross pathology :

Multipite grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive mammary carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and single cells infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures. No carcinoma insitu component is seen.

Immunohistochemical Result;

ER: Positive strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining of >10% tumor cells (score 1+) Her2 low

Ki67: Positive nuclear staining of 5% of tumor cells.

Diagnosis:Left breast mass,tru cut biopsy:

Invasive mammary Carcinoma, (NST) Grade II.

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient ID: 95382	Patient Name English: Manal Said Farag
Age: ٢٧ سنة, ٢ شهر	2026/05/13 11:54:06 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 50 y old lady coming for routine screening.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR B).
- UOQ area of architectural distortion associated with indistinct mass.
- **Ultrasound** demonstrated corresponding irregular indistinct hypoechoic mass with echogenic rind noted at 12 o'clock zone b measuring about 12x8mm ,being about 80mm from the nipple and 5mm from overlying skin.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Right breast

- Scattered fibro glandular densities (ACR B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Left breast (BIRADS 4B): UOQ suspicious mass for biopsy and histopathological assessment

Right breast (BIRADS 1): Normal study.

Recommendations:

Annual screening mammogram.

Dr.Reham Rady,FEBR,FFBR.

Patient's Name:

Manal Said Farag Mahmoud



Date:

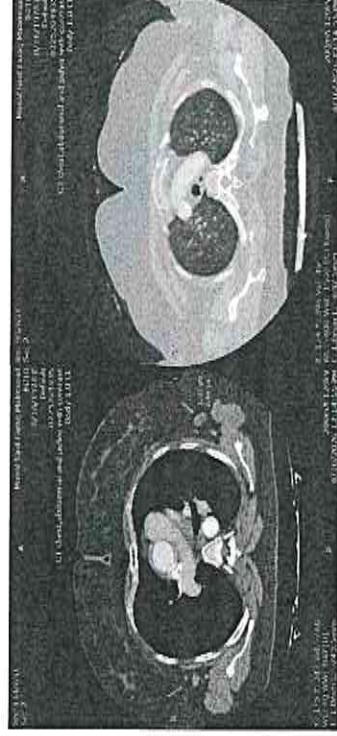
2026-08-16

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt



**MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST ,ABDOMEN AND PELVIS WITH
CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-**

- Bilateral axillary lymph nodes are seen with loss of their hilar fat contents and the largest one measures about 24 mm in the left side.
 - Hyperinflated both lungs.
 - Mild reticulations are seen in the lingula with thin linear atelectatic bands seen in the middle lobe,lingula and both lower pulmonary lobes.
 - Ground glass opacities are seen scattering in both lung fields.
 - No sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules or foci of calcifications noted.
 - No sizable abnormally-enhancing mediastinal or hilar lymph nodes seen.
 - Patent central airways.
 - No pleural or pericardial effusions.
 - Average size of the heart with normal CT of its big vessels.
 - Normal bones of the thoracic cage.
 - Enlarged lobes of the beaver-tail liver, measuring about 16.5cm and 16.2cm respectively ,showing diffuse reduced parenchymal attenuation and a homogenous enhancement pattern.
 - No sizable abnormally-enhancing focal lesions or dilated biliary radicles.
 - Patent PV.
 - Average sized spleen,measuring about 9.5 cm. No focal lesions seen inside.
 - Thickened left supra-renal gland.
 - Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, right suprarenal gland, aorta and IVC.
 - No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
 - No ascites.
 - No intra-vesical stones,solid masses,wall thickening or diverticulosis seen.
 - The rest of the pelvic structures are unremarkable.
 - No definite lytic or sclerotic lesions
- IMPRESSIONS:**

- **Bilateral axillary lymphadenopathy. For clinical correlation.**

Patient's Name:

Manal Said Farag Mahmoud



Date: 2026-08-16

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Mild reticulations in the lingula with thin linear atelectatic bands in the middle lobe, lingula and both lower pulmonary lobes, and ground glass opacities scattering in both lung fields, likely to be a post-therapeutic/inflammatory reactions respectively.
- Relatively thickened left adrenal gland, likely to be a hyperplasia.
- Hepatomegaly with fatty infiltration and no focal lesions.

Prof/Hanan El-Ahwal.

مستشفى
روسي
مصر



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الكلية الطبية
مصر

08/30/2026

MDT FORM

Name:	Manal محمود	MRN:	12132
Age:	48 Y	ID:	27811092100987
Menopausal Sta	post	Phone:	0113827326
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMT:		Family History:	
CO Morbidity:	HTN , hx of disc prolapse surgery	Reason Of MDT:	new

Clinical Data:

R

L

BX: LT invasive mammary Carcinoma, (NST) Grade II

ER: 8/8 **PR:** 7/8 **HER2:** 1+ **KI67:** 5

Sonomammography:

ACR B

LT breast 12 o'clock zone b
measuring about 12x8mm, being about 80mm from the nipple and
5mm from overlying skin.

Normal skin and nipple/areolar complex.

Preserved axillary LNs

Impression:

LT breast (BIRADS 4B): UOQ suspicious mass for biopsy and
histopathological assessment

Right breast (BIRADS 1): Normal study

Mets Workup:

CT:

Bilateral axillary lymphadenopathy. For clinical correlation.

- Mild reticulations in the lingula with thin linear atelectatic bands in the middle lobe, lingula and both lower pulmonary lobes, and ground glass opacities scattering in both lung fields, likely to be a post-therapeutic/inflammatory reactions respectively.

- Relatively thickened left adrenal gland, likely to be a hyperplasia.

History:

clinically: no palpable lesions

NOTE no comment of axial skeleton on CT report (requested)

In view of being T1 N0 >> for possibility of upfront LT wire localization + WLE
+ SLNB

omnla essayy

Recommendations:

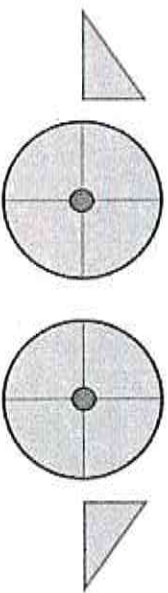
MDT Outcome & Plan

Review mammosonography films at surgery clinic +/- target AxUS (??no
palpable AxLN despite CT reporting of them)...then proceed with wire
localization then Lt WLE & SLNB accordingly.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. هبة هادي	د. لؤي عيسى				

Signature



TNM